

TEMA 2.6 • TRAUMATOLOGÍA

Politraumatismos y Fractura de Pelvis

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **politraumatismo** se define como la lesión de al menos **tres sistemas** (ej. gastrointestinal, genitourinario y locomotor) o la afectación de tres o más órganos de sistemas diferentes que ponen en riesgo la vida del paciente. Su manejo debe ser sistemático, priorizando siempre la estabilidad vital sobre las lesiones evidentes pero no letales.

Etiología y Epidemiología

Las causas más frecuentes de politraumatismo en Chile son: 1. **Accidentes de tránsito:** Es la causa principal. Los atropellos son especialmente letales, siendo los ocurridos en carretera los de mayor mortalidad, seguidos por los de ciudad. 2. **Caídas de altura:** Frecuentes en contextos laborales o accidentales. 3. **Agresiones:** Heridas por arma blanca o de fuego.

Evaluación Inicial: El ABCDE del Trauma

El manejo del paciente politraumatizado sigue un orden estricto de prioridades. No se debe avanzar al siguiente paso sin haber resuelto el anterior.

TABLA 2.6.1: LETRA VS SIGNIFICADO

LETRA	SIGNIFICADO	ACCIONES CLAVE
A	Airway (Vía aérea)	Asegurar permeabilidad de la vía aérea e instalación de collar cervical .
B	Breathing (Ventilación)	Asegurar que el paciente ventile. Uso de Ambú o ventilación mecánica si es necesario.
C	Circulation (Circulación)	Instalar 2 vías venosas gruesas, infusión de cristaloides (Suero Fisiológico) y compresión de hemorragias externas .
D	Disability (Déficit neurológico)	Realizar examen neurológico completo (Escala de Glasgow, pupilas) para descartar lesión medular o TEC.
E	Exposure (Exposición)	Desvestir completamente al paciente para buscar lesiones ocultas, evitando la hipotermia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el manejo de la circulación (C), si te preguntan qué es más urgente entre comprimir una hemorragia activa o instalar la vía venosa, la respuesta suele ser **comprimir primero** para detener la pérdida de volemia.

NOTA CLÍNICA

La A no solo implica que el aire pase, sino proteger la médula espinal. Todo paciente politraumatizado se considera portador de una lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario.

Estudio Radiológico Inicial

En todo paciente politraumatizado, independientemente de la clínica, se debe solicitar de forma sistemática la "trilogía radiográfica": 1. **Radiografía de Columna Cervical (Lateral):** Para descartar fracturas o luxaciones que comprometan la médula. 2. **Radiografía de Tórax (AP):** Para buscar **Neumotórax**, **Hemotórax** o contusión pulmonar. 3. **Radiografía de Pelvis (AP):** Fundamental para detectar fracturas de pelvis que pueden causar hemorragias masivas.

Adicionalmente, se pedirán radiografías específicas de las zonas donde se sospeche fractura por el mecanismo del trauma o deformidad evidente.

Fractura de Pelvis

La fractura de pelvis suele presentarse en el contexto de un paciente politraumatizado. Es una lesión de alta energía con un potencial de mortalidad elevado debido a complicaciones vasculares y viscerales.

Evaluación Específica

Además del ABCDE, en la fractura de pelvis es obligatorio realizar: - **Tacto rectal y vaginal:** Para descartar que se trate de una **fractura expuesta** hacia la mucosa rectal o vaginal, lo cual requiere antibióticos y cirugía de urgencia. - **Evaluación de la estabilidad pélvica:** Maniobras de compresión-distracción (aunque deben hacerse con precaución para no aumentar el sangrado).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si sospechas una fractura de pelvis, evita realizar maniobras repetidas de estabilidad pélvica, ya que puedes romper coágulos formados y reactivar una hemorragia venosa masiva.

Complicaciones Graves

Existen dos complicaciones clásicas que son frecuentemente preguntadas:

- #### 1. Shock Hipovolémico
- Es la causa principal de muerte inmediata.
- Origen:** Generalmente es por sangrado de los **plexos venosos pélvicos** (hemorragia venosa), aunque también puede haber compromiso arterial.
- Manejo:** Reposición de volumen con cristaloides y **estabilización precoz de la pelvis**.
- Métodos de estabilización:**
 - Férula neumática (pantalón antichoque).
 - Tutores externos (quirúrgico).
 - Hamaca pélvica.
 - **Sábana pélvica:** En APS o lugares sin recursos, enrollar una sábana apretada alrededor de las trocánteres mayores para cerrar el espacio pélvico.
- #### 2. Sección Uretral
- Frecuente en fracturas de la sínfisis del pubis (lesiones en "libro abierto").
- Sospecha:** Sangre en el meato urinario, próstata flotante al tacto rectal o globo vesical.
- Diagnóstico:** Uretrocistografía retrógrada.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: Está prohibido instalar una **sonda Foley** ante la sospecha de sección uretral, ya que puede agravar la lesión o crear una falsa vía. El manejo inicial del globo vesical debe ser mediante una **cistostomía suprapúbica**.

Resumen de Manejo

1. **ABCDE** (Prioridad absoluta). 2. **Estabilización de pelvis** (si hay sospecha de fractura o inestabilidad hemodinámica). 3. **Radiografía AP de Pelvis** para confirmar diagnóstico. 4. Manejo de complicaciones (cirugía, antibióticos en fracturas expuestas, cistostomía en lesiones uretrales). **Shock Insuficiencia Respiratoria Traumatismo Encefalocraneano**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Politraumatismos y Fractura de Pelvis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El politraumatismo es trauma de al menos tres sistemas; sus causas más frecuentes son accidentes de tránsito y caídas de altura.
- El estudio mínimo incluye tres radiografías: lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis.
- El tratamiento sigue el ABCDE: vía aérea con collar, ventilación, circulación con dos vías venosas y cristaloides, déficit neurológico y exposición.
- La fractura de pelvis siempre requiere tacto rectal y vaginal para descartar fractura expuesta hacia esas cavidades.
- El shock hipovolémico en fractura de pelvis es por lesión de venas pélvicas; se trata con ABC más estabilización externa de la pelvis.
- La sección uretral en fractura de pelvis contraindica absolutamente la sonda Foley; se trata con cistostomía, uretrocistografía y cirugía.
- La estabilización pélvica reduce la capacitancia y frena la hemorragia venosa; puede hacerse con sábana enrollada si no hay otro recurso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (POLITRAUMATISMOS Y FRACTURA DE PELVIS)**PREGUNTA 1**

Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?

- A)** Anteroposterior de tórax, anteroposterior de abdomen y lateral de rodilla
- B)** Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis
- C)** Anteroposterior de tórax, TAC de cerebro y anteroposterior de pelvis
- D)** Solo anteroposterior de tórax si el paciente está estable
- E)** Radiografías de todos los huesos largos más AP de tórax

PREGUNTA 2

Un paciente con fractura de pelvis en libro abierto tras un accidente de tránsito está en shock hipovolémico. ¿Cuál es la conducta más urgente para controlar la hemorragia?

- A)** Transfusión de glóbulos rojos y esperar que se estabilice solo
- B)** Cirugía de pelvis de urgencia para clipar las venas pélvicas
- C)** ABC más estabilización externa de la pelvis con sábana, amaca o tutores externos
- D)** Instalar sonda Foley para medir diuresis y controlar hidratación
- E)** Angiografía pélvica para embolizar las arterias sangrantes

PREGUNTA 3

Un paciente con fractura de pelvis no puede orinar y presenta dolor suprapúbico. Usted sospecha sección uretral. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Instalar sonda Foley con cuidado para drenar la vejiga
- B)** Cistostomía suprapúbica, uretrocistografía y reparación quirúrgica de la uretra
- C)** Uretrocistografía primero y luego sonda Foley si la uretra está íntegra
- D)** Observar y esperar que orine espontáneamente
- E)** TAC de pelvis para ver la extensión de la fractura

RESUMEN: POLITRAUMATISMOS Y FRACTURA DE PELVIS

El politraumatismo se define como trauma de al menos tres sistemas diferentes. Sus causas más frecuentes son los accidentes de tránsito, especialmente atropellos, y las caídas de altura. El enfrentamiento inicial requiere como mínimo tres radiografías: lateral de cuello para descartar fractura cervical, anteroposterior de tórax para descartar neumotórax o hemotórax, y anteroposterior de pelvis para descartar fractura de pelvis. El tratamiento sigue el ABCDE: A de vía aérea permeable con collar cervical, B de ventilación con ventilación asistida si es necesario, C de circulación con dos vías venosas gruesas y cristaloideas más compresión de heridas, D de déficit neurológico con examen neurológico completo, y E de exposición desvistiendo al paciente para buscar lesiones ocultas. La fractura de pelvis habitualmente ocurre en el contexto de un politraumatismo. Siempre se debe realizar tacto rectal y vaginal para descartar que sea una fractura expuesta hacia esas cavidades. La complicación más grave es el shock hipovolémico por lesión de las venas pélvicas. El tratamiento es el ABC más estabilización de la pelvis, que puede hacerse con férula neumática, tutores externos, amaca pélvica o en su defecto una sábana enrollada comprimiendo la pelvis. La estabilización reduce la capacitancia pélvica y frena la hemorragia venosa. La segunda complicación importante de la fractura de pelvis es la sección uretral. En este caso está absolutamente contraindicado instalar una sonda Foley porque puede crear una falsa vía y generar más daño. El manejo correcto es cistostomía si hay globo vesical, uretrocistografía retrógrada para el diagnóstico y reparación quirúrgica de la uretra. La sonda Foley está contraindicada si se sospecha sección uretral.